

הגישה למטופל כוללת שלושה שלבים:

- פנייה מילולית
- יצירת יחסי שיתוף פעולה
- הרגעה מילולית.

הרגעה מילולית זאת, המשולבת בשיתוף פעולה של המטופל, היא בדרך כלל המפתח להפיכתו לשותף פעיל בהערכת מצבו הרפואי ובטיפול בו. כך גם לגבי תכנון המשך הטיפול ולגבי טיפול תרופתי - רצוי שהוא ייתן בהסכמת המטופל.

לטיפול במטופל הפסיכיאטרי הסוער ארבע מטרות:

- (1) להבטיח את שלומם של המטופל, הצוות ואנשים אחרים הנמצאים במקום
- (2) לסייע למטופל להשיג שליטה רגשית והתנהגותית
- (3) להימנע ככל האפשר מהגבלות כגון קשירה
- (4) להימנע ככל האפשר מהפעלת טיפול כפוי שעלול לגרום להחרפת המצב הסוער

ההנחיות לגישה למטופל הסוער כוללות 10 המלצות (שהן נכונות גם עבור כל מטופל):

- (א) כבדו את המרחב של המטופל
- (ב) אל תהיו פרובוקטיביים
- (ג) צרו קשר מילולי
- (ד) היו מדויקים
- (ה) זהו רצונות ורגשות
- (ו) האזינו היטב לדברי המטופל
- (ז) הסכימו או הסכימו שלא להסכים
- (ח) הסבירו את כללי ההתנהגות ושימו גבולות ברורים למטופל
- (ט) הציעו ברירות והביעו תקווה
- (י) תדרכו את המטופל ואת הצוות

מצבי חירום בהתמכרויות

מצבי החירום הקשורים לשימוש בחומרים ממכרים מופיעים בדרך כלל בהרעלות ובגמילה, וגם בעקבות שימוש ממושך בחומרים אלה. אפשר לחלק מצבים אלה גם למצבי חירום גופניים ולמצבי חירום פסיכיאטריים.

יש לזכור שחלק ניכר מהמשתמשים והמכורים, משתמשים בכמה חומרים שונים, ולכן להשלמת הבירור יש תמיד לבדוק את פרופיל הסמים בדם ובשתן.

הגדרות

סם - חומר הגורם להתמכרות

שלבי ההתמכרות - התרגלות או תלות

- (1) **התרגלות (עמידות, tolerance)** - הצורך להעלות את כמות החומר הממכר כדי להשיג את אותה ההשפעה.
 - (2) **תלות (dependence)** - מצב שבו מופיעה תסמונת גמילה בשל הפסקה בנטילת הסם.
- סכנות השימוש בחומרים ממכרים**

- (1) **סכנות רפואיות**
בעקבות שימוש - הרעלות עד סכנת מוות ומחלות נלוות (גופניות ופסיכיאטריות)
בעקבות גמילה - פיתוח תסמונות גמילה עד סכנת מוות
- (2) **סכנות חברתיות**
פגיעה באורח החיים התקין, כולל פגיעה בתפקוד המשפחתי, החברתי והמקצועי;
פיתוח התנהגות עבריינית.

טבלה 20.1 סוגי סמים וסכנותיהם בהרעלה, במנת יתר ובגמילה

סוגי סמים וסכנותיהם		
סוג הסם	סכנה בהרעלה, במנת יתר	סכנה בגמילה
אלכוהול	- שכרות - איבוד הכרה - סכנת מוות	- התכווצויות אפילפטיות - סכנת מוות - דליריום טרמנס (delirium tremens), מצב בלבול חריף שהוא תסמונת מסוכנת ביותר
בנזודיאזפינים (ואליום)	אין סכנה ניכרת (בבליעת טבליות)	- התכווצויות אפילפטיות - סכנת מוות
ברביטורטים	- פגיעה במרכזים מוחיים - סכנת מוות	- התכווצויות אפילפטיות - סכנת מוות
אופיאטים (הרואין)	הפסקת נשימה וסכנת מוות	אין סכנה ניכרת

טיפול בהרעלות ובגמילה צריך להתבצע לפי המסוכנות של החומרים הממכרים ובהשגחה רפואית!

התמכרויות וסכנה אובדנית

מתמכרים עלולים להגיע למצב מסכן חיים בשל נטילת מנת יתר של החומר הממכר. התמכרות היא הסיבה השנייה בשכיחותה להתאבדויות באוכלוסייה הכללית, ולכן בכל מקרה של טיפול חירום במתמכרים יש לשלול סכנה זאת.

סכנה אובדנית והתאבדויות

גישת הטיפול באובדנות וניסיונות התאבדות

תגובה נכונה של המגיבים הראשונים, ובראשם צוותי הרפואה המטפלים בנפגעים אובדניים, חשובה ביותר הן בטיפול המיידי באנשים לאחר ניסיון אובדני, והן בהתייחסות לבני משפחותיהם ולחבריהם של מתאבדים. יחס נכון, תומך, מתחשב ולא שיפוטי, ובלי להצדיק את ההתנהגות האובדנית - הוא חיוני.

במקרי התאבדויות - חשוב מאוד השיתוף של גורמי התמיכה בקהילה עבור הקרובים.

מקובל לראות מדרג של מחשבות אובדניות, פגיעות עצמיות (ניסיונות אובדניים) והתאבדויות. ואולם, הקביעה החשובה בעת הערכת סכנה אובדנית היא אם מדובר ברצון להפסיק סבל נפשי שהאדם, המנסה להתאבד או המאיים להתאבד, אינו יכול לשאתו, או שמדובר בקריאה לעזרה וברצון לקבל התייחסות מהסביבה. מרבית הניסיונות האובדניים הם מסוג קריאה לעזרה, אך יש חשיבות לשלילת סכנה אובדנית מוחשית.

יש חפיפה מסוימת בין התאבדויות לניסיונות אובדניים: כשליש מהמתאבדים ניסו להתאבד בעבר; התקופה הנחשבת למסוכנת היא כשלושה חודשים לאחר הניסיון הקודם. כן יש לזכור כי ניסיון אובדני קודם מגדיל את הסכנה האובדנית פי 10 ויותר.

ההבדל המהותי בין רוב ההתאבדויות ובין רוב הניסיונות להתאבד הוא שהמתאבד מעוניין למות כדי להפסיק סבל נפשי קשה ואילו המנסה להתאבד מעוניין ליצור תגובה של הסביבה (קריאה לעזרה).

בעוד ניסיונות אובדניים שכיחים יחסית יותר בקרב צעירים, ומעט יותר בקרב נשים, ההתאבדויות שכיחות יותר בקרב גברים מבוגרים ובודדים.

התסמונות הנפשיות העיקריות הקשורות לאובדנות הן דיכאון רבא, דיכאון מזוירי (מחלת הדיכאון; דיכאון קליני), התמכרויות וסכיזופרניה, ומרבית המתאבדים סובלים מהפרעות אלה.

הערכת הסכנה האובדנית

סימנים מדאיגים - ביצוע פעולות של פרידה, השארת מכתב פרידה, מצב נפשי לאחר פרידה מדמות קרובה, תחושת כישלון והיעדר תמיכה, במיוחד בקרב אנשים שיש להם אישיות מופנמת, קווים סכיזואידיים (מופנמות קיצונית), אנשים תלתיים או הימנעתיים. בעת הבדיקה יתגלה שאין אצל האדם תחושת הקלה לאחר כישלון הניסיון האובדני.

סיכון לעומת סיכוי - מבצעים הערכה של מסוכנות המעשה מול הסיכוי להינצל. כלומר - מה הסיכון האפשרי שבמעשה האובדני כמו: ירייה, תלייה, קפיצה מגובה רב, נטילת כמות קטנה של תרופה לא מזיקה, לעומת הסיכוי להינצל מביצוע המעשה במקום מבודד ולחלוף בנזכחות בני אדם.

מדיניות הטיפול בניסיונות האובדניים - בהיעדר מחלת נפש, מעטים המקרים שמסתיימים באשפוז, ואם בכל זאת האדם מאושפז האשפוז יהיה קצר.

תוכניות מניעה - בצה"ל יש תוכנית רב-שנתית שהביאה לירידה משמעותית של התאבדויות חיילים בשירות חובה. משרד הבריאות מקיים תוכנית מיוחדת להכשרת שומרי סף לזיהוי סכנה אובדנית.

הערכת סכנה אובדנית - היא חלק הכרחי בבדיקה הנפשית. אם עולה חשד, אין לחשוש לשאול את הנבדק שאלה ישירה: "האם ניסית להתאבד או חשבת על כך?" יש לעשות זאת באמפתיה, תוך שמירה על פרטיות הנשאל. בדרך כלל אם התשובה חיובית - שיחה אוהדת על מצוקות הנבדק שהביאו למחשבה האובדנית תביא להקלה בהרגשתו.

בהערכה הפסיכיאטרית המלאה שלילת אובדנות היא חלק מהבדיקה - אף אם לא עולה לכך חשד.

כאשר סיבת הבדיקה היא הערכת הסכנה האובדנית, על הבודק לברר באמפתיה את כל הנקודות העיקריות האלה כדי להחליט על המשך הטיפול הרצוי.

גישה חיובית - במקרים שבהם מטפלים במי שניצלו מניסיון אובדני, יש להימנע מגישה שיפוטית - אך גם להימנע מהצדקת המעשה האובדני: יש לעודד את המטופל ולנסות לחזק גישות חיוביות ותכונות חיוביות שלו. הגישה של הפסיכולוגיה החיובית הופכת בשנים האחרונות למרכזית בפסיכיאטריה: התמקדות בצדדים האופטימיים של הקיום והימנעות מעיסוק בפתולוגי ובשלילי. לכן, חלק חיוני בגישה הטיפולית במקרים אלה הוא הדגשת הציפייה להחלמה מלאה. בשנים האחרונות מודגש תחום ההחלמה והצמיחה הפוסט-טראומטית - יכולתם של נפגעי טראומה לצאת מחוזקים. לפי גישה זו יש להתייחס למי שניצל מניסיון אובדני משמעותי על ידי עידודו, ויש להדגיש את הסיכוי לשיפור מלא במצבו.

תמיכת הסביבה - בכל מקרה, גם במקרים שבהם לא רואים שמדובר בכוונה למות, יש לחזק ככל האפשר את התמיכה הסביבתית של הנפגעים: לדאוג לתמיכה בהם על ידי בני משפחתם, חברים, חברים לעבודה, ואם הנסיבות מתאימות, גם תמיכה של גורמים בארגון שאליו הם משתייכים, כגון מקום עבודה.

אשפוז - במקרים שבהם יש סכנה אובדנית מוחשית אך אין מקום לאשפוז פסיכיאטרי בניגוד להסכמת המטופל מנסים לדאוג למצב של אשפוז בית, כלומר להשגחה מלאה מתמשכת של קרובים אחרים. וכן, יש לדאוג להשאיר דלת פתוחה להמשך טיפול וסיוע נפשיים, גם אם המטופל אינו מעוניין בכך בעת הבדיקה.

הנחיות לפעולה במטופל האובדני

- התייחסו לכל התנהגות אובדנית וניסיון אובדני
- דאגו לביטחונם של כל הנוכחים
- הרחיקו חומרים וכלים מסוכנים, ובעת הצורך הזעיקו עזרה כולל עזרת המשטרה
- יש לטפל ראשית בכל המצבים הגופניים הדחופים של המטופל האובדני, כמו שינוי במצב ההכרה או קשיי נשימה
- יש ליצור קשר עם המטופל, לדבר איתו בצורה רגועה ותומכת, להסביר את המצב ולברר במה המטופל יכול לסייע
- יש להשגיח על המטופל ללא הפסקה ולדאוג לכך שלא יוכל לנסות לפגוע בעצמו
- אספו חומרים ותרופות שייכתן שנטל ומביאים אותם לחדר המיון
- פנו את המטופל לחדר מיון. אם המצב לא ברור והמטופל מסרב, יש להתייעץ עם הממונים כיצד לפעול.

בדיקה והערכה של מקרה החשוד כאובדני

- העריכו את המצב הגופני וטפלו בו
 - העריכו את המצב הנפשי:
- « עודדו את הנבדק לדבר ולספר כיצד הוא מרגיש
- « אם הנבדק לא פגע בעצמו - שאלו שאלות לגבי כוונות אובדניות למשל: "האם אתה חושב לפגוע בעצמך? למות?" אם התשובה חיובית: "האם תכננת כיצד לעשות זאת?"
- אין לחשוש משאלות כאלה - נשאלים רבים חשים הקלה מכך שניתן להם לשוחח על הרגשתם.
- שאלו לגבי גורמי הסיכון להתאבדות:
- « האם הנבדק בדיכאון? האם אינו רואה כל תקווה למצבו?
- « אם ניסה להתאבד - האם עשה זאת כדי להפסיק סבל נפשי שלא היה מסוגל לעמוד בו או שביקש לשנות את התייחסות הסביבה כלפיו?
- « האם הוא סובל משימוש לרעה בסמים/ אלכוהול/ תרופות הרגעה או מההתמכרות אליהם?
- « האם הוא סובל מהפרעה נפשית כגון סכיזופרניה?
- « האם טופל בתרופות פסיכיאטריות, ואם כן: באילו תרופות?
- « האם ביצע פעולות של פרידה כמו השארת מכתב אובדני?
- « האם נפרד לאחרונה מדמות קרובה (מוות או פרידה)?
- « האם חש תחושת כישלון והיעדר תמיכה?
- « אם ניצל מניסיון אובדני רציני: האם חש הקלה?
- בצעו הערכה של מסוכנות המעשה/ התכנון האובדני - סיכון לעומת סיכוי.
 - שאלו לגבי ניסיונות אובדניים קודמים. אם היו, מה כללו ומה קרה בעקבותיהם כגון: האם היה בטיפול נפשי?

מניעת הפרעות פוסט־טראומטיות: תוכנית מד"א

התגובה השכיחה לאירועים טראומטיים, כולל מצבי חירום ואסון, היא פיתוח חוסן ואף צמיחה פוסט־טראומטית. מעקב ארוך טווח אחרי נפגעי טראומה, וברובם ניצולי השואה, העלה ממצאים חיוניים הרבה יותר מהמצופה. ממחקרי מעקב בישראל עולה ששיעור ההפרעות הפוסט־טראומטיות בקרב כלל האוכלוסייה בישראל הוא נמוך יחסית לארצות אחרות ושיעור ההפרעות הפוסט־טראומטיות בקרב ניצולי השואה בישראל אף נמוך מבני גילם באוכלוסייה הכללית.

הופעת חרדה משתקת בעקבות אירוע דחק משמעותי, בדרך כלל כזה המאיים על הקיום, היא חלק הכרחי של האבחנה "הפרעה פוסט־טראומטית", שהפכה מאז חיבור המדריך הפסיכיאטרי האמריקאי המודרני הראשון, DSM-3, בשנת 1980, לאבחנה הראשית של התגובות הנפשיות לטראומה.

מלבד ההפרעה הפוסט־טראומטית, ייתכנו תגובות נפשיות אחרות לאירועי דחק. אולם, מאחר שזאת התסמונת השכיחה מבין התגובות הנפשיות, ומאחר שבמתווה של אירוע רב־נפגעים אין אפשרות לאבחן כל נפגע בצורה יסודית, מקובל להתייחס לכל נפגעי הנפש בעקבות אירוע דחק כאל נפגעי ההפרעה, כלומר כאל נפגעי תגובת דחק חריפה (acute stress reaction).

בטיפול בנפגעים בשגרה ובחירום נחשפים צוותי מד"א הן לנפגעים הסובלים מתופעות נפשיות והן למצבי חירום טראומטיים ובהם: אירועים מרובי נפגעים (אר"ן), אירועים שהם סכנה לצוות, ואירועים נוספים העלולים לגרום להופעת תופעות נפשיות תגובתיות. כדי לתת מענה מיטבי לנפגעים על צוותי מד"א לתת עזרה ראשונה גם בתחום הנפשי כחלק מהמענה הרפואי בחירום ובשגרה. כמו כן, על חברי הצוות לדעת לזהות סימני לחץ נפשי אצל עמיתיהם ואצל עצמם כדי למנוע התפתחות של תופעות שחיקה או סימפטומים פוסט־טראומטיים.

תסמונת פוסט־טראומטית, תסמונת בתר־חבלתית (Post-Traumatic Stress Disorder: PTSD)

תסמונת נפשית תגובתית שלא תטופל כראוי תתקבע ותהיה תסמונת בתר־חבלתית (תסמונת פוסט־טראומטית, post-traumatic stress disorder: PTSD). התסמונת מאופיינת בארבע קטגוריות מרכזיות של תסמינים: (1) חודרנות (2) הימנעות (3) עוררות יתר ו־ (4) דיכאון או פגיעה קוגניטיבית. תסמינים אלה מתקבעים אצל חלק מהנחשפים לאירוע טראומטי משמעותי קיצוני, בדרך כלל כזה שהוא איום קיומי. ככל שהתסמונת ממושכת, סיכויי ההחלמה ממנה קטנים יותר, ולכן יש להדגיש את חשיבות המניעה הראשונית (לפני אירוע הדחק), השניונית (מייד לאחר אירוע הדחק), והשלישונית (טיפול מיידי מיטבי לאחר הופעת הפרעה).

תגובת הדחק החריפה (Acute Stress Reaction: ASR)

תגובת הדחק החריפה (ASR) מבטאת את התגובה המיידית לאירוע טראומטי ויכולה להימשך כמה שעות ועד שלושה ימים לאחר האירוע. הביטוי הטיפוסי שלה הוא הלם המלווה בניתוק ובקושי להגיב לסביבה באופן מתאים. תגובה כזאת נחשבת לתקינה ולא לפתולוגית אם היא חולפת תוך 48-72 שעות.

התסמינים בתגובה החריפה לדחק יכולים להתבטא בחרדה, דיכאון, כעס, ייאוש, ניתוק, התכנסות וקפיאה או פעילות יתר ללא מטרה. בדרך כלל התגובה תחלוף בעקבות טיפול יחסי הסביבה או אף ללא טיפול.

הפרעת הדחק החריפה (Acute Stress Disorder: ASD)

הפרעת דחק (ASD) היא תופעה פתולוגית, להבדיל מתגובת דחק. ההפרעה מאובחנת כאשר התסמינים נמשכים לאחר 48-72 שעות מהחשיפה לאירוע הדחק המחולל הטראומטוגני ועד חודש אחריו. כלומר זהו בדרך כלל המשך ישיר של תגובת הדחק החריפה שהנחשף לא הצליח להתגבר עליה בימים הראשונים. ההפרעה מוגדרת בתסמינים בתרחבלתיים החל משלושה ימים לאחר האירוע.

תסמונת פוסט־טראומטית, תסמונת בתרחבלתית (Post-Traumatic Stress Disorder: PTSD)

תסמונת פוסט־טראומטית (PTSD) מאובחנת כאשר הפרעת הדחק אינה נפסקת, והיא נמשכת לאחר חודש ימים מהאירוע הטראומטי. אם התסמונת נמשכת לאחר חודש מהאירוע הטראומטי היא מכונה תסמונת חריפה (Acute PTSD). לאחר שלושה חודשים היא תסמונת כרונית (Chronic PTSD). מטרת ההתערבות בשלבים אלה היא למנוע הפרעה מתמשכת.

התסמונת מאופיינת בארבע קטגוריות עיקריות של תסמינים והן: חודרנות, הימנעות, עוררות יתר, ודיכאון או פגיעה קוגניטיבית.

חודרנות - חוויה חוזרת של האירוע הטראומטי המתבטאת בחזרה לא רצונית של תמונות, זיכרונות ומחשבות הקשורים לאירוע. אלו חודרים אל המודעות, בזמן השינה - בצורת חלומות שבהם הנפגע חוזר לחוות את האירוע; במצבי ערות - תופעה המכונה פלשבק (הבזק). וכן החמורה מבין תופעות הניתוק - דיסוציאציה (dissociation) - המאפיינות את התסמונת. כל אלה מצטרפים אל הרגשת החרדה הקיומית שאפיינה את אירוע הדחק.

הימנעות - קהות רגשית וצמצום עניין בעולם החיצוני, אובדן עניין בנושאים שבהם היה לנפגע עניין בעבר, תחושת בידוד וניכור שמשקפים ניסיונות להימנע מגירויים העלולים להזכיר את האירוע הטראומטי.

עוררות יתר - עירור יתר המתבטא בין השאר בסף רגישות נמוך לגירויים, קשיי ריכוז, הפרעות בשינה ועצבנות כללית.

דיכאון, פגיעה קוגניטיבית - לאחרונה נוסף קריטריון רביעי זה לרשימת הקריטריונים של איגוד הפסיכיאטריה האמריקאי.

בכל השלבים של מניעת הפרעות נפשיות בעקבות אירועי דחק משתמשים בקווים מנחים פסיכולוגיים לניהול נכון של שיחה לאחר טיפול של צוותי התערבות - צוותי חירום והצלה כגון צוותי מד"א, לוחמי אש (כבאים) ואנשי פיקוד העורף באירועים טראומטיים. ניהול נכון של שיחה זאת, תחילה על ידי תרגול, בשלב המניעה הראשונית, ולאחר מכן מייד לאחר אירוע טראומטי, בשלב המניעה השניונית, מאפשר גם את המניעה השלישונית - זיהוי של אנשי צוות שפיתחו בכל זאת סימפטומים פוסט־טראומטיים, והפנייתם לטיפול מידי.

מנחה השיחה הוא איש צוות בכיר - בצבא זהו מפקד הצוות ובארגונים אזרחיים זהו מנהל או מרכז.

חשוב לפעול לפי עקרונות השיטה גם באירועים שאינם אירועי דחק רבי־נפגעים, ובכל אירוע שבו ניתן טיפול המערב תגובות רגשיות אצל אנשי הצוות. השיחה תתקיים קרוב ככל האפשר לסיום טיפול הצוות באירוע. עליה לכלול סקירה של האירוע הטראומטי כולל פעילות אנשי הצוות במהלכם ושלב של איסוף כוחות וסיכומים. יש לעודד את אנשי הצוות, להדגיש את חשיבות פעילותם, ולהשרות ציפייה לתפקוד מיטבי בהמשך.

טיפול מיידי בנפגעי דחק

על הטיפול בנפגעי דחק (כמו בטיפול במשבר) להיות טיפול קרוב ככל האפשר למקום הפגיעה, באופן מיידי, תוך שידור ציפייה להחלמה. הטיפול יתבסס על שלושה היבטים שאותם אפשר לסכם בראשי התיבות: קמ"ץ: קרבה, מיידיות וציפייה (Proximity Immediacy Expectancy: PIE).

ק	קרבה
מ	מיידיות
צ	ציפייה

בודקים את הנפגעים בדיקה גופנית מלאה לשלילת גורם גופני לתגובה הנראית כתגובת דחק נפשית. גם בדיקה זאת נעשית תוך יצירת קשר טיפולי חיובי עם הנפגעים.

יש לדאוג להחזרת חסכים פיזיולוגיים כגון: שתייה ואוכל, לבוש הולם וביטחון - יש לנהל את הטיפול במקום מוגן ובטוח כל האפשר.

- הצלחת כל טיפול נפשי תלויה בהצלחת קשירת קשר טיפולי, בהשגת הרגשת המטופלים שהמטפלים משקיעים בהם את הידע המקצועי המיטבי שלהם מתוך רצון כן לסייע להם ומתוך גישה אמפתית. אמפתיה = העברת ההרגשה למטופלים שהמטפלים מסוגלים להבין ולחוש את מצוקותיהם.
- יצירת קשר טיפולי חיובי היא השלב הראשון, ואולי החשוב ביותר, גם בטיפול הנפשי המיידי בנפגעי דחק.

יצירת הקשר הטיפולי

- (1) הציגו עצמכם בפני הנפגע, בשמכם ובתפקידכם
- (2) הביעו התחייבות לסייע לו
- (3) נסו לנהל את המפגש בגובה העיניים: בישיבה ובעמידה או בהליכה משותפת אם אין מדובר בנפגע עם פגיעה גופנית
- (4) הימנעו מעימותים עם הנפגע
- (5) מסרו משוב תומך במפגש
- (6) מסרו לנפגע את הידוע לכם לגבי אירוע הדחק, אם הדברים אינם ברורים להם

המשך הטיפול המיידי בנפגעי דחק

- קבלת מידע (פרטים מזהים, סיפור הפגיעה הטראומטית)
- מתן מידע, אוריינטציה
- הימנעות מעימות או ביקורת ומתן עידוד ומשוב חיובי
- נפגעים פוסט-טראומטיים (בכל שלבי התסמונת) מעוניינים לשמוע שהם אנשים רגילים, המגיבים בתגובה רגילה לסיטואציה לא רגילה.

- **הפעלה** - אם המצב מאפשר, נותנים לנפגעים אפשרות לפעול ולהביא תועלת בפעולותיהם כדי להפחית את תחושת חוסר האונים שלהם.
- **הרגעה התנהגותית** - במקרים שבהם הנפגעים ממשיכים להפגין חרדה שאינה מאפשרת את הטיפול, אפשר להרגיעם הרגעה התנהגותית. הטיפול ההתנהגותי מבוסס על התיאוריה שאי אפשר להיות רגוע וחרד בה בעת. לכן, יצירת מצב של רגיעה גופנית תביא בהכרח לרגיעה נפשית. את הרגיעה הגופנית משיגים על ידי טכניקות שונות, שהמשותף לכולן הוא האטת הנשימה על ידי נשימה איטית ועמוקה.
- טיפולים נוספים - במצבים דחופים קשים במיוחד של הפרעות הדחק יש צורך בהתערבות תרופתית. כך גם כאשר יש הפרעות ניכרות בשינה. מקובל להשתמש בתרופות ההרגעה, רובן מקבוצת התרופות נוגדות הדיכאון והחרדה.

פסיכולוגיה חיובית במניעה ובטיפול בהפרעות דחק

הגישה החיובית בפסיכולוגיה, ההולכת ומתבססת כגישה מרכזית בתחום, נכללת בתוכנית מד"א באופן ישיר בין היתר בהיבטים אלו:

- עקרונות הקמ"ץ, הכוללים את הציפייה להחלמה מהירה ומלאה כחלק מהנאמר למטופלים
- הקביעה שמדובר בתגובה רגילה של בני אדם רגילים - לסיטואציה לא רגילה
- התרכזות בהווה ובעתיד ולא בפתולוגיה של העבר
- אפשר להדגיש לנפגעים שהתוצאה השכיחה לטראומה היא צמיחה פוסט־טראומטית ורכישת חוסן

דוגמאות של צורות פנייה חיוביות לנבדקים ולמטופלים

- תנו מחמאות עקיפות - **"כיצד עשית זאת?"** ולא - **"האם עשית זאת?"**
- הדגישו את הצלחת הנבדקים לתפקד
- שאלו: **"למה אתה מקווה בעתיד?"** ולא - **"האם יש לך תקווה לעתיד?"**
- שאלו: **"מיהם האנשים החשובים עבורך, ומה התכונות שלהם שאתה מעריך?"** ולא - **"האם יש אנשים שאתה מעריך?"**
- הביעו הערכה לידע של הנבדקים בתחום שעליו אתם דנים
- בררו את הסיבה לדעת הנבדקים לצורת התנהגותם, ועודדו אותם להסיק בעצמם מה היו יכולים לעשות טוב יותר

החלמה וצמיחה פוסט־טראומטית

על פי המודל של קלהון וטדסקי (Calhoun & Tedeschi)

- (1) **הרגשה מחוזקת של עוצמה אישית** - "אני פגיע יותר מכפי שחשבתי, אבל הרבה יותר עמיד מכפי שהעליתי על דעתי"
- (2) **זיהוי אפשרויות לשינוי בדרך החיים** - פיתוח שטחי עניין חדשים, פעילויות חדשות ושינויי קריירה
- (3) **התפתחות קשרים בין־אישיים טובים יותר** - הרגשת קשר חזק יותר לאחרים, הבנת סבל וחמלה כלפי הסובלים

- (4) **הערכה רבה יותר של החיים** - ושינויים בסדרי העדיפויות בשל שינוי תפיסת העולם
- (5) **התפתחות רוחנית או דתית** - בעקבות שינוי תפיסת העולם, מציאת משמעות קיומית; התפתחות דתית רואים בעיקר אצל נפגעים דתיים

מניעת טראומטיזציה משנית ושחיקה אצל צוותי חירום והצלה

חשיפה מתמשכת לקורבנות טראומה עלולה לגרום לטראומטיזציה משנית (vicarious, compassion fatigue, traumatization). כאשר מופיעים סימנים לכך יש לטפל בנפגעים אלה כבנפגעי טראומה נפשית. קיום נוהלי שיחת הצוות במד"א מאפשר הן מניעה של טראומטיזציה משנית והן זיהוי של אנשי צוות הזקוקים לסיוע נוסף. גם בשגרה חשוב לזהות אם עמיתים לשירות במד"א מגלים שינויים מדאיגים במצב רוחם או בתפקודם.

תגובות אפשריות בעקבות טיפול בנפגעים

- "האם עשינו כל מה שאפשר להציל חיים, האם פעלנו נכון?"
- שנאה, כעס, דחייה - "צריך יותר ציוד", "אין לי גישה לנפגעים"
- חוסר אונים, פחד וחרדה - "היו יותר מדי נפגעים"
- חשש מפגיעה, "לא מאמין שזה קורה" ובשל זה התפתחות הפרעה פוסט־טראומטית
- אשמה, עצב, בדידות - "הנפגע מת וזו אשמתי", "אני היחיד שמרגיש כך", "יחשבו שאני חלש"
- תחושת אובדן - אובדן התמימות, אובדן היעילות

עצות שימושיות לצוותים

- שמרו על כושר גופני
- צאו להפסקות מדי פעם
- אכלו ארוחות מאוזנות ושתו מספיק
- עבדו במשמרות סבירות
- חפשו סימני דחק - אצלכם ואצל חבריכם
- הישארו פעילים
- אל תתפסו עצמכם כ"משוגעים"
- דברו עם חברים, משפחה, עמיתים

אם הסימפטומים נמשכים פנו לעזרה מקצועית.

מסירת הודעה על מוות

עיקר ההודעות הקשות שעל צוותי מד"א למסור הן הודעות על מוות - מאחר שבמקרים אחרים מטרת הטיפול היא ייצוב, טיפול או פינוי. בישראל גובשה תורה למסירת הודעות קשות, על ידי ענף הנפגעים ההיסטורי של צה"ל. תורה זאת מתאימה, תוך ההתאמות המתחייבות, למצבים שבהם על צוות מד"א למסור למשפחת הנפטר או לאחרים הקרובים אליו על מותו.

הכללים למסירת הודעה על מוות

- מסירת ההודעה תהיה בדרך כלל על ידי איש הצוות הבכיר, שהוא המנוסה ביותר במסירת הודעות קשות
- רצוי שההודעה תינתן לאחר הבנת הקרבה של הנוכחים לנפטר, ולאחר היכרות מסוימת עימם כדי להתאים את ההודעה למקבליה
- על ההודעה להימסר ככל האפשר בצורה שקטה, לקרובים ביותר לנפטר, תוך הבעת צער והבנת מצבם

תגובות אפשריות להודעה

- בכי, עצב, אי־שקט, חרדה
- אצל ילדים תיתכן גם התנהגות נסיגתית
- היעדר כל תגובה - גם כן תיתכן, והיא מעידה על ניתוק
- כעס - מאחר שמדובר בנוכחות צוות מד"א, יש במקום צוות רפואי. במקרה שבו הצוות ניסה להחיות את האדם שנפטר וההחייאה היתה בנוכחות הקרובים - אין להתעלם מכך, ואפשר אף לצפות לתגובות של כעס.

הודעות לילדים על מוות במשפחה

רצוי להודיע לילדים בנוכחות הורה (ההורה הנותר במקרה של מות אחד ההורים), בן משפחה אחראי או דמות קרובה (מורה). דרושה היכרות מסוימת עם הילד כדי להבין כיצד למסור את ההודעה, לפי יכולות ההבנה וההכלה של הילד.

מוסר ההודעה - לפי הנסיבות ולפי רצון המשפחה. מסירת ההודעה יכולה להיות בתוך המשפחה ללא מעורבות מטפלים. אפשר להיעזר גם ביועץ של פסיכולוג ילדים.

מושג המוות אצל ילדים

הבנת המוות - אי־הפיכות, כוללניות, חוסר אפשרות מניעה, וסיבתיות

עד גיל 7	אי אפשר להסביר סיבתיות
7-10	קיימת הבנה מסוימת, אך אין יכולת התגברות עצמית
אחרי גיל 10	תגובות דומות למבוגרים
בגיל 10-15	השלמת ההבנה

מסקנה: אין למסור הודעה על פטירה לילד ללא נוכחות מבוגר קרוב.

רצוי לדאוג לסיוע לקרובי הנפטר, למשל לקשר אותם עם בני משפחה אחרים.

יש לזכור שמקבלי ההודעה נמצאים במצב משברי, ועלולים לא לקלוט היטב את הנמסר להם. לכן יש להעביר את ההודעה בצורה ברורה, ולהסביר היטב פרטים מעשיים לגבי המשך התנהלותם, כגון קבלת תעודת פטירה, הודעה לאחרים והובלת הנפטר.

חשוב לערוך שיחת צוות לאחר כל מסירת הודעה על מוות - גם במקרים שבהם לא בוצעה החייאה. תשומת לב מיוחדת יש לתת לאנשי צוות שנחשפו לראשונה למקרה פטירה ולמתנדבי הנוער. גם אנשי צוות ותיקים ומנוסים זקוקים לתמיכה לאחר מקרים אלה - והיא תינתן להם מעצם עריכת שיחת הצוות.

ער"ן: עזרה ראשונה נפשית דרך הטלפון והאינטרנט

פנייה לעזרה ראשונה נפשית נעשית כיום פעמים רבות באמצעות התקשרות דרך הטלפון, האינטרנט ואמצעי תקשורת נוספים. בישראל הגוף העיקרי העוסק במתן סיוע נפשי כזה הוא אגודת ער"ן (עזרה ראשונה נפשית בטלפון ובאינטרנט).

המפגש של צוותי מד"א עם מטופלים ובני משפחותיהם, שהוא בדרך כלל מפגש יחיד, מקביל למעשה למצב של שיחה יחידה לער"ן ומרבית העקרונות הטיפוליים האלה מתאימים גם למד"א.

הפניות לקווי ער"ן הן אנונימיות - הן הפונים והן המתנדבים המשווחחים איתם אינם מזוהים, ומטרתן העיקרית של השיחות היא הצעת סיוע נפשי באמצעות הקשבה, תמיכה ועידוד, דרך הטלפון או בעזרת המסך והמקלדת. ואולם, אנונימיות זו מופרת כאשר נוצר אצל המתנדבים חשש לסכנה אובדנית מוחשית וממשית אצל המתקשר - המטרה היא להגיע פיזית לפונים הנמצאים בסכנה.

לפניות כאלה יתרונות רבים:

- בעצם הפנייה עוברים הפונים מחסום של סטיגמה מפני טיפול נפשי ושל רתיעה מלהודות בחולשה, ובפנייתם הם מביעים תובנה לכך שעליהם לקבל סיוע נפשי
- יש הרואים בעצם הפנייה חלק ניכר מתהליך ההחלמה
- לאנונימיות של הפונים והמסייעים יש יתרון בכך שהפונים מרגישים ביטחון לגלות את מצוקותיהם ללא חשש. למעשה - נוצר בשיחה קשר טיפולי מובהק וזאת אף שמרבית המתנדבים בקווי מצוקה כגון ער"ן, בארץ ובעולם, אינם אנשי מקצוע מתחום מקצועות בריאות הנפש.
- חלק ניכר מהפונים סובלים מבידוד וכמה מהם סובלים מהפרעות נפשיות ממושכות. כמה מהם מביעים מחשבות אובדניות - ולכן קווים אלה נקראים קווים חמים - הם הופכים לכאלה בעת זיהוי סכנה אובדנית מוחשית.

עקרונות הסיוע הנפשי

עקרונות הסיוע הנפשי דומים לעקרונות הכלליים של הטיפול במקצועות בריאות הנפש:

- יכולת הקשבה פעילה** - יש לקבל את הפונה כמות שהוא, תוך העברת מסר חיובי. יש לדבר בכנות ולבטא אמפתיה, לשדר לפונה שאתם מסוגלים להבין אותו מתוך נקודת מבטו ולחוש את מצוקתיו.
- יש להימנע** - מלהיות שיפוטיים, ממתן עצות ומהצעת פתרונות מעשיים לבעיות שמעלים הפונים; יש להימנע מלהטיף מוסר לפונים.
- אין להימנע מהתמודדות עם דברי הפונים** - אין להתעלם מהם או להחליף נושא
- אין לחקור** את הפונים בשאלות מיותרות
- אין להתנשא** - לבטא פטרונות, ציניות או לעג, אין להתווכח עם הפונים
- אין לבטא חוסר סבלנות**
- אין לנתח או לאבחן** את הפונים
- ואין לשים את עצמנו במרכז** כמו לספר על עצמנו רוב השיחה

כללים אלה נכונים למעשה למרבית המצבים הטיפוליים.

התוכנית הלאומית לעזרה ראשונה נפשית: מודל מעש"ה

התוכנית הלאומית לעזרה ראשונה נפשית פותחה על ידי ד"ר משה פרחי מהמכללה האקדמית תל חי ומופצת על ידי משרד הבריאות. בבסיסה של התוכנית: הקניית מיומנויות למי שאינם מטפלים, כדי ללמדם כיצד לטפל באחרים המפתחים מצב דחק נפשי.

התוכנית נקראת מודל מעש"ה וכוללת ארבעה עקרונות עיקריים להגשת סיוע ראשוני רגשי במצבי מצוקה וחרדה (לשימוש כלל האוכלוסייה):

מ	מיקוד תקשורת
ע	עידוד לפעילות יעילה
ש	שאלות מחייבות חשיבה
ה	הבניית האירוע והדגשת סיום האירוע

מודל מעש"ה הוא הנגשה של מודל מעט רחב יותר המכונה SIX C's והמשלב עקרונות קודמים של חוסן ועמידות, כולל מודל המסוגלות של Bandura, מודל תחושת הקוהרנטיות של אנטונובסקי ומודל העמידות של Maddi ו-Kobasa. ששת עקרונות הסיוע של מודל 6 ה־C הם:

Cognitive-Communication	תקשורת קוגניטיבית	תקשורת קוגניטיבית עם המטופל
Challenge-Control	אתגר־שליטה	הפעלה מאתגרת של המטופל לקבלת החלטות ולהחזרת תחושה של שליטה
Commitment	מחויבות	מחויבותו של המטופל אל המטופל
Continuity	המשכיות	הנחיית המטופל להבניית האירוע

חשיבותו של מודל ה־SIX C's, וכן של מודל מעש"ה הנגזר ממנו, טמונה בהנגשת כלים לסיוע מידי רגשי, כלים שאינם תלויים בנוכחותו של מטפל מקצועי בעת התרחשותו של אירוע מעורר דחק. לא זו בלבד, אלא שיישומם של מודלים אלה מאפשר התערבות טרם החשיפה לאירוע מעורר הדחק, ובכך הם עשויים לסייע במניעת היווצרותם של תסמיני דחק ואף במניעת הופעתה של הפרעה פוסט־טראומטית.

מודל מעש"ה התקבל על ידי חיל הרפואה של צה"ל כתוכנית המג"ן (מוביל גיוס חוסן נפשי) והמשכיה: הכשרת הלוחמים עצמם לזהות תגובות קרב אצל חבריהם ולהתערב באופן מהיר וחד, כדי שבתוך דקות ספורות יהיה אפשר להחזיר את החייל הנמצא במצב של הלם קרב לתפקוד, ולשפר את הבניית האירוע ואת חוויתו וזיכרונו לגבי האירוע. תוכנית זו הוכנסה לראשונה במבצע צוק איתן (2014), וכיום נכללת בתוך הכשרת לימוד עזרה ראשונה של כל לוחם בצה"ל.

דוגמה לפעולת התערבות נכונה לפי התוכנית היא הדרך שבה מוקדני מד"א מנחים את הפונים למוקד בזמן אירוע טראומטי כשהם בסערת רגשות.

טיפול כפוי בחולי נפש

הבסיס החוקי לטיפול במטופל עם הפרעה נפשית מתבסס, נוסף על חוק זכויות המטופל, גם על החוק לטיפול בחולי הנפש משנת 1991.

יש להדגיש שחוק זה חל רק על מי שאובחן כחולה נפש. על האבחנה להיעשות על ידי פסיכיאטר שהוסמך על ידי פסיכיאטר מחוזי, וכדי להגיע לבדיקה יש לקבל החלטה של פסיכיאטר מחוזי או של בית משפט.

החוק אינו מגדיר מהן מחלות הנפש, אך על פי תקדימים משפטיים מקובל לקבוע שמדובר במחלות שבהן יש מצב פסיכוכי המערב הפרעה בחשיבה - בייחוד אצל מטופלים עם סכיזופרניה.

צו בדיקה - במקרים שבהם יש חשד שחולה נפש עבר עבירה פלילית אין לפנות לפסיכיאטרי מחוזי אלא למשטרה. במקרה כזה עלול המטופל להגיע לבדיקה - לעיתים בהסתכלות - בצו של בית משפט (צו בדיקה).

צו אשפוז - אם הבדיקה תגלה שבעת ביצוע העבירה לא היה המטופל אחראי למעשיו או שכעת הוא אינו מסוגל לעמוד לדין בגלל מצבו הפסיכיאטרי, הוא יישלח על ידי בית המשפט לאשפוז פסיכיאטרי בצו אשפוז.

הוראת בדיקה - ואולם, במקרים טרום-אשפוזיים קלאסיים, שבהם יש חשש שחולה נפש עלול להיות מסוכן לעצמו או לאחרים, באופן מיידי או בשל הזנחה עצמית מתמשכת, אפשר לפנות לפסיכיאטר מחוזי בבקשה להוצאת הוראת בדיקה. בדיקה כזאת נעשית על ידי הפסיכיאטר המחוזי או אחד מסגניו (שלהם סמכויות זהות) או על ידי פסיכיאטר מומחה שמונה על ידו. הבדיקה תהיה בדרך כלל בחדר מיון פסיכיאטרי או במרפאה פסיכיאטרית ציבורית. מטרת הבדיקה היא להעריך את מסוכנותו של המטופל לעצמו או לאחרים.

הוראת אשפוז - אם בבדיקה נמצאת מסוכנות של המטופל לעצמו או לאחרים, אפשר לאשפז את המטופל בהוראת אשפוז - והוא יועבר לאשפוז כפוי במחלקה פסיכיאטרית שנקבעת על ידי הפסיכיאטר המחוזי (או סגנו). יש שני סוגים של הוראת אשפוז: דחופה, ולא דחופה - ועליה המטופל יכול לערער בתוך חמישה ימים בפני ועדה פסיכיאטרית מחוזית.

במקרים שאין מדובר במי שכבר אובחן בעבר עם מחלת נפש - יש להיזהר מלהשתמש בחוק הטיפול בחולי הנפש, ולפעול על פי ההיגיון הרפואי הטיפולי. גם כאן יש חשיבות רבה לקשר הטיפולי שנוצר עם הנבדק כדי לשכנע את המטופל להסכים לפינוי לחדר מיון. בדרך כלל מאחר שקשה לקבוע בבדיקה אחת ללא בדיקות עזר מקיפות אם אין מדובר בהפרעה אורגנית-מוחית, יש היגיון בהפניית הנבדק לחדר מיון כללי, לשלילת אבחנה מסוכנת כזאת.